

الإمساك هو وجود براز نادر، أو صلب، أو يصعب إخراجة. وهو شائع جداً — ويؤثر على صحة الحوض لأن الإجهاد الناتج عنه يزيد من هبوط الأعضاء ولسلس البول والألم الحوضي. والبشرى أن معظم حالات الإمساك تتحسن بتغييرات بسيطة وفعالة.

عن هذه الحالة

ينبغي أن تمر حركات الأمعاء الطبيعية دون إجهاد. تشمل علامات الإمساك: التبرز أقل من ثلاث مرات أسبوعياً، والبراز الصلب أو المتكتل، والإجهاد، والشعور بإفراغ غير كامل، أو الحاجة إلى الضغط حول المهبل أو المستقيم لإخراج البراز ("التدعيم").

الأسباب

- قلة الألياف والسوائل وعدم كفاية النشاط البدني
 - تجاهل الرغبة في التبرز
 - الأدوية — المواد الأفيونية، والحديد، وبعض غيرها
 - مشكلات قاع الحوض — عدم استرخاء العضلات للسماح بخروج البراز (إمساك "المخرج")
 - تباطؤ حركة القولون
- إمساك "المخرج" مهم: يُعالج بعلاج قاع الحوض، وليس بالمليينات فقط.

تعلم المصطلحات

الإمساك

براز نادر أو صلب أو يصعب إخراجة.

الألياف

مواد نباتية تُلّين البراز وتزيد حجمه.

ملين أسموزي

عامل لطيف (مثل PEG) يجذب الماء إلى البراز.

إمساك المخرج

صعوبة في إخراج البراز بسبب عدم استرخاء عضلات الحوض.

التغذية الراجعة الحيوية (Biofeedback)

علاج يُعيد تدريب العضلات على الاسترخاء لإتمام حركة الأمعاء.

التدعيم (Splinting)

الضغط قرب المهبل أو المستقيم لمساعدة البراز على المرور.

لماذا يهتم طبيب المسالك البولية بالإمساك؟ لأن الإجهاد لإخراج براز صلب يضغط على نفس الدعامة التي تحمل المثانة وأعضاء الحوض — فيزيد الإمساك من هبوط الأعضاء وسلس البول، كما أن المستقيم الممتلئ يضغط على المثانة. وتحسين الإمساك غالباً يُخفف أعراض المثانة أيضاً.

كيف تُعالج (خطوة بخطوة)

معلومات مفيدة

- أضف الألياف **ببطء** لتجنب الانتفاخ، واشرب ماءً كافياً معها.
- المليينات المحفزة مقبولة أحياناً؛ استشر فريقك قبل استخدامها يومياً.
- إذا كان الإجهاد هو المشكلة الرئيسية، فقد تكون المشكلة في تنسيق العضلات — والعلاج الطبيعي أجدى من مزيد من المليينات.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- دم في البراز، أو فقدان وزن غير مبرر
- إمساك جديد لا يتحسن، خاصةً في كبار السن
- ألم بطني شديد، أو قيء، أو انعدام الغازات والبراز (احتمال انسداد)

ثلاثة أمور تتذكرها

1. الإمساك شائع ويؤثر على صحة الحوض — فالإجهاد يزيد من هبوط الأعضاء وسلس البول.
2. عالجه بالألياف والسوائل والنشاط وعادات تبرز سليمة (كرسي للقدمين، بلا إجهاد)، ومليينات لطيفة عند الحاجة.
3. إذا استمر الإجهاد، اسأل عن علاج قاع الحوض. وأبلغ عن دم في البراز أو فقدان وزن أو تغيير مفاجئ شديد.

1. **الألياف والسوائل والنشاط** — زد الألياف تدريجياً (من الطعام أو المكملات) مع شرب كميات كافية من الماء.
2. **عادات التبرز** — اذهب عند الشعور بالرغبة، واستخدم كرسيًا للقدمين لرفع الركبتين (وضعية القرفصاء)، ولا **تجهد نفسك**.
3. **مليينات لطيفة** — العامل الأسموزي (مثل PEG) آمن للاستخدام المنتظم عند الحاجة.
4. **علاج قاع الحوض / التغذية الراجعة الحيوية** لإمساك المخرج؛ وراجع الأدوية المسببة للإمساك مع فريقك الطبي.

روتين صحي

- حاول التبرز في **نفس الوقت يومياً**، غالباً بعد وجبة.
- امنح نفسك وقتاً غير متسرع؛ لا تُجبر نفسك أو تجهدها.
- ابقَ نشطاً — حتى المشي اليومي يساعد الأمعاء على الحركة.